

03 - 03- Communication, Soutien Psychologique et Éthique en Soins Palliatifs - Pr. HACHIMI

(0:00 - 0:33)

Bonjour, c'est Professeur Hashimi. Notre troisième cours s'intitule Communication, soutien psychologique et éthique en soins palliatifs. Les objectifs de ce cours sont communiquer et soutenir psychologiquement le patient et son entourage, décrire les principes d'éthique en soins palliatifs, décrire les symptômes de l'agonie et accompagner les proches en deuil.

(0:35 - 1:11)

Les compétences d'un soignant en soins palliatifs sont avoir une attitude de compassion en étant attentif aux souffrances, aux attentes et aux peurs du malade et sa famille. La compassion, c'est le sentiment de partager les souffrances, c'est de la sympathie. Montrer un engagement pour les soins palliatifs, avoir du respect pour chaque malade en le considérant comme un individu unique et autonome et pas juste un cas de maladie ou un numéro de chambre ou de lit.

(1:13 - 2:07)

Tenir compte des cultures et des valeurs personnelles de la famille et du malade, avoir une bonne communication pour avoir un consentement éclairé du malade ou de ses proches. Les aptitudes du soignant en soins palliatifs sont fournir les soins médicaux et infirmiers adaptés au stade de la maladie et au pronostic, fournir des soins centrés sur le malade et ses proches, fournir des soins en considérant tous les aspects de la souffrance physique, psychique, spirituelle et sociale. Assurer la continuité des soins, faire une évaluation continue des soins.

(2:09 - 2:51)

La communication est un processus dynamique au cours duquel deux personnes échangent et partagent des informations, des idées, des opinions, des sentiments ou des réactions. Ceci implique l'écoute, l'échange, le partage et l'ouverture. Ceci nous permettra de motiver et de convaincre le malade et ses proches en tenant compte de leurs besoins, de leurs préoccupations, de leur culture et de leurs réactions et leurs expériences.

(2:52 - 3:52)

Une bonne communication nécessite ne pas être pressé, permettre à l'autre de s'exprimer, de répondre, ce qui permet de tisser un lien avec le malade et ses proches, utiliser sa voix avec un temps doux, avec un rythme lent et calme. Avoir une attitude d'écoute, c'est être assis à la même hauteur en répétant ou en formulant les propos du malade pour s'assurer qu'il a bien compris. Respecter l'autre sans jugement de valeur, écouter pour comprendre, y compris les silences, utiliser ses sens, le regard, le toucher et enfin utiliser les feuilles de transmission pour exprimer le

ressenti pour favoriser le travail d'équipe.

(3:55 - 4:43)

En matière de communication, le malade a le droit de prendre des décisions éclairées après une large information, déterminer le but des soins, établir des priorités de traitement à partir des choix thérapeutiques disponibles, changer d'idée à n'importe quel moment, donner librement son consentement avant de recevoir un traitement et peut en demander l'arrêt. Et enfin, désigner un décideur, c'est un substitut qui peut prendre des décisions à la place du malade. Et surtout, il ne faut pas que l'équipe soignante impose des choix thérapeutiques au malade et à sa famille.

(4:44 - 6:20)

Prendre des prétextes de l'incapacité physique ou psychique pour prendre des décisions thérapeutiques inaltérales, ne pas tenir compte de la culture, de la religion, de la personnalité, de l'état émotionnel, du niveau du développement intellectuel du malade ou de sa famille ou ne pas tenir compte de la décision du malade de refuser ou d'arrêter toute intervention thérapeutique. Une bonne communication commence déjà dès l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou d'une maladie grave. C'est une stratégie qui se base sur ces étapes.

La première, c'est préparer l'entretien dans un lieu privé en impliquant la famille, disposer du temps nécessaire, être assis et être en relation par les yeux et le toucher. La deuxième étape, c'est évaluer la perception, poser des questions ouvertes pour évaluer la perception et la compréhension du patient et de la famille, corriger les informations fausses éventuelles, chercher si le patient est dans le déni, c'est-à-dire il prend ses désirs pour des réalités ou il oublie l'essentiel des points médicaux défavorables. La troisième étape, c'est obtenir l'invitation du malade pour lui exposer ce qu'il souhaite savoir.

(6:22 - 7:09)

La quatrième étape, c'est donner l'information. Donner l'information souhaitée par le patient, s'adapter à son niveau de compréhension, ne pas utiliser des mots techniques, vérifier régulièrement la bonne compréhension et éviter les phrases négatives. La cinquième étape, c'est répondre aux émotions du malade avec empathie, observations des émotions, pleurs, silences, tristesse, lui dire qu'on est en lien avec lui, se rapprocher de lui, lui toucher le bras ou la main.

(7:09 - 7:33)

Si le patient est silencieux, l'interroger pour partager sa colère. La sixième étape et la dernière, c'est résumer et proposer un plan thérapeutique. Écouter les souhaits du patient, ses peurs, ses angoisses, vérifier l'absence d'erreurs de compréhension et de les corriger.

(7:33 - 8:11)

Avant de discuter d'un plan thérapeutique, s'assurer que le patient est prêt à le faire, présenter les options thérapeutiques disponibles et enfin s'assurer que le patient va recevoir le traitement approprié et la continuité des soins pour maintenir l'espoir. Après l'annonce d'une mauvaise nouvelle, le patient réagit en passant par des étapes. Premièrement, le choc émotionnel, puis la dénégaration où il nie la réalité.

(8:12 - 8:29)

Après, c'est la colère ou la rage, souvent contre celui qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Puis la récrimination temporaire ou le marchandage avec une prise de conscience graduelle. La dépression.

(8:30 - 9:06)

Et enfin l'acceptation qui permet de retrouver un nouveau sens à la vie avec de nouveaux intérêts. Le soutien psychologique c'est la mise en œuvre de moyens basés sur l'écoute, la parole et l'observation pour secourir le patient avec des difficultés psychologiques. Le soutien psychologique, il vise le malade, la famille et les soignants aussi.

(9:08 - 10:33)

Il se base sur une bonne connaissance des soins palliatifs, savoir approcher et soutenir le malade, savoir quand référer le patient en cas de difficultés psychiques à un spécialiste et avoir un groupe de parole des soignants pour soutenir psychologiquement l'équipe soignant. Les techniques du soutien psychologique se basent sur l'écoute sans jugement, l'observation de tout ce qui n'est pas verbalisé, les postures, les gestes, la détection de l'expression émotionnelle, le toucher, le réconfort et le soutien moral, la référence du malade face à des difficultés spécifiques nécessitant l'intervention de spécialistes. Et il faut envisager la référence à un psychologue ou un psychiatre devant la persistance de signes morbides malgré un soutien psychologique de base, devant des idées autodestructrices au suicidaire, devant une dépression, devant des troubles psychiatriques.

(10:37 - 10:51)

On peut énumérer cinq principes éthiques. Premièrement, la bienveillance. La bienveillance, c'est chercher à faire du bien en améliorant le confort du patient et de sa famille.

(10:52 - 11:28)

Cela concerne surtout les actes médicaux qui doivent éviter le double effet, c'est-à-dire un traitement qui apporte peu ou pas de guérison et qui peut multiplier le mal-être. Deuxièmement, éviter la malveillance. Troisièmement, la justice, qui consiste à essayer d'être le plus juste possible, surtout la justice distributive en donnant à la personne ce qu'elle mérite selon ses droits.

(11:30 - 12:09)

Le quatrième principe, c'est l'autonomie, qui permet de valoriser la liberté de conscience du patient avec le respect du secret des croyances et des choix. Le cinquième principe, c'est le droit de douter. Il faut laisser au malade le droit de douter, de poser des questions, de discuter, ce qui permet de protéger l'équipe soignante et la famille du sentiment de culpabilité et de l'épuisement.

(12:11 - 12:52)

Le malade a le droit de connaître sa maladie, son principe et les interventions médicales ou diagnostiques à subir, mais il faut donner l'information que le malade souhaite savoir, mais ne pas le forcer à l'informer. Le discernement, c'est la distinction, c'est l'opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée. C'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses.

(12:52 - 13:09)

Il comprend quatre étapes successives. Premièrement, le malade doit être capable de recevoir et de comprendre les informations. Deuxièmement, il doit pouvoir faire une opinion.

(13:10 - 13:37)

Troisièmement, il doit être conscient de la relation entre l'information qu'il a eue, la décision qu'il va prendre et les conséquences. Quatrièmement, il doit faire connaître sa décision au médecin. Et enfin, aucun acte médical ne peut être imposé sans accord libre et éclairé de la part du malade.

(13:38 - 14:03)

Le consentement libre et éclairé c'est une décision de la part du malade exempte d'erreurs, de tremperie ou de contraintes extérieures. C'est un contrat qu'il est le patient et son médecin. Le patient et le médecin doivent se comprendre sur la signification des termes utilisés.

(14:04 - 15:04)

La situation palliative vise à soulager une détresse devant un symptôme réfractaire sévère sur une pathologie avec un pronostic de quelques jours à semaines. Le patient et ses proches doivent être informés sur les objectifs et les risques avec un consentement éclairé sinon le représentant thérapeutique avec un consensus au sein de l'équipe soignante sur les objectifs et les modalités. L'acharnement thérapeutique c'est toutes les situations décisionnelles qui conduisent à mobiliser de façon excessive des moyens humains, matériels et techniques dans l'intention de vouloir contrôler à tout prix un état morbide chez un patient dont le pronostic de vie est très réservé.

(15:05 - 15:40)

Il est déraisonnable et critiquable de poursuivre une lutte acharnée surtout si les moyens employés sont pénibles pour le patient sans espoir à une vie de qualité. L'euthanasie est interdite à ce jour. C'est tout acte qui met fin de façon délivrée à la vie d'un patient atteint d'une maladie incurable et évolutive et qui en fait la demande réitérée.

(15:41 - 16:12)

Le concept du double effet peut s'appliquer en soins palliatifs. Par exemple, utiliser de grandes doses d'antalgique pour soulager un patient même si la survenue du décès est susceptible d'être accélérée parce que l'action est légitime par le but recherché. Ce concept du double effet doit répondre à quatre critères.

(16:13 - 16:24)

L'intention doit être bonne. L'effet secondaire doit être prévisible. L'effet secondaire ne constitue pas le moyen d'obtenir l'effet recherché.

(16:25 - 16:58)

Et l'effet recherché doit l'emporter sur l'effet secondaire. La spiritualité est une démarche cognitive qui pousse l'homme à chercher un sens et un but à son existence. Elle peut être fondée sur des croyances religieuses, études philosophiques, morales, artistiques ou scientifiques.

(16:59 - 17:44)

Et elle peut entraîner des pratiques dites spirituelles. Après l'annonce d'une maladie grave, le patient peut soit avoir un début ou un approfondissement de sa spiritualité, soit inversement, elle peut entraîner l'arrêt conduisant le patient à une indifférence à son identité spirituelle avec la mort de son soi et l'éclatement de son identité spirituelle. Sur cette plaque, on a une échelle qui peut évaluer la détresse spirituelle chez un malade en soins palliatifs.

(17:48 - 19:10)

L'agonie est précédée par une augmentation graduelle de la somnolence et de la faiblesse musculaire, un changement de la respiration type Cheinstocks, une hypotension artérielle avec une oligoanémie, un changement de la couleur de la peau avec des extrémités froides et une agitation et trouble de conscience. L'agonie se caractérise par un arrêt de l'activité, une épovigilance progressive jusqu'au coma, une fluctuation de la température, un changement du rythme respiratoire avec des râles agoniques et une dysphagie. La prise en charge du deuil commence avant le décès par garantir une prise en charge globale du patient et de sa famille, maintenir un niveau d'information honnête, évaluer et prendre en charge les besoins de la famille, informer sur toutes les ressources sociales et sanitaires disponibles, faciliter et promouvoir les

réconciliations entre familles et évaluer les facteurs de risque de deuil compliqués.

(19:13 - 20:34)

Au moment du décès, contrôler les symptômes d'une manière adéquate, informer sur l'évolution de la situation et des symptômes, favoriser l'expression des émotions, prévenir les sentiments de culpabilité, faciliter les rituels religieux et spirituels et faciliter les démarches administratives en relation avec le décès. Après le décès, encourager la personne en deuil à le vivre dans le même lieu partagé avec le défunt, encourager la personne en deuil à ranger et réorganiser les affaires du défunt, informer sur les manifestations normales du deuil, informer sur la disponibilité des unités spécialisées en deuil au niveau des unités de soins palliatifs et identifier les personnes qui présentent des deuils compliqués et chercher les facteurs de risque. Concernant le deuil, on est devant deux catégories de deuil, soit un deuil normal résolu avec la capacité de parler du défunt sans émotions visibles, la capacité de reprendre une vie normale et un deuil pathologique.

(20:35 - 23:39)

Le deuil pathologique se reconnaît lorsque la personne se replie sur elle-même refusant de reprendre son courant de vie normal avec trois types, un deuil compliqué avec une extériorisation tardive des symptômes de deuil, un deuil pathologique psychiatrique avec apparition des délires ou des obsessions, des symptômes hystériques ou obsessionnels durables et un deuil pathologique somatique avec apparition des somatisations surtout des symptômes cardiaques. Les facteurs de risque d'un deuil compliqué ce sont des facteurs relationnels, perdre un fils ou une fille, un conjoint, une mère ou un père à un âge précoce, avoir une relation de dépendance, avoir une relation conflictuelle ou ambivalente et ces facteurs peuvent être d'ordre circonstanciel un âge jeune du défunt, une mort subite, une maladie et agonie prolongée, un cadavre non récupéré et un mauvais souvenir du processus de la maladie. Ces facteurs de risque peuvent être d'ordre personnel une personne en deuil jeune ou âgée, difficultés de gérer le stress, antécédents psychiatriques, sentiments intenses de colère ou de culpabilité, deuil antérieur non résolu, absence d'occupation ou d'intérêt et des facteurs de risque sociaux avec absence de soutien des réseaux sociaux familiales ou entourage conflictuel un manque de ressources socio-économiques avoir des enfants de bas âge et un milieu professionnel conflictuel et enfin des facteurs de risque pour les enfants et les adolescents avec un environnement instable absence d'une figure responsable sentiments d'abandon et de solitude dépendance d'un parent en deuil compliqué relation négative avec la nouvelle figure morte de la mère pour les filles jeunes ou du père pour les garçons adolescents et le manque de discipline pour l'enfant et l'adolescent Merci pour votre attention